

Tiroidectomía – Indicaciones y complicaciones

1. Introducción y relevancia clínica

La **tiroidectomía** es la cirugía que consiste en la **extirpación parcial o total de la glándula tiroides**, indicada en enfermedades benignas o malignas que no responden a tratamiento médico o presentan riesgo oncológico.

En Chile, los motivos más frecuentes de tiroidectomía son:

- **Nódulo tiroideo sospechoso o confirmado de cáncer.**
- **Bocio multinodular sintomático o compresivo.**
- **Hipertiroidismo refractario al tratamiento médico.**

Es una **cirugía de alta frecuencia**, pero con riesgos específicos (daño nervioso, hipocalcemia) que deben prevenirse y reconocerse precozmente.

2. Fisiopatología y bases conceptuales

2.1 Anatomía relevante

- La glándula tiroides se ubica en la cara anterior del cuello, sobre la tráquea, con dos lóbulos laterales y un istmo.
- Recibe irrigación de:
 - **Arteria tiroidea superior (rama de la carótida externa).**
 - **Arteria tiroidea inferior (rama del tronco tirocervical).**
- Drenaje venoso: plexo tiroideo medio e inferior.
- Relación anatómica clave:
 - **Nervio laríngeo recurrente (NLR):** pasa posterior a la glándula, entre el esófago y la tráquea.
 - **Nervio laríngeo superior (rama externa):** inerva el cricotiroides.

- **Glándulas paratiroides:** adosadas a la cara posterior del tiroides (generalmente 4).

2.2 Tipos de tiroidectomía

Tipo	Extensión	Indicaciones principales
Lobectomía (hemitiroidectomía)	Extirpación de un lóbulo y el istmo	Nódulo único sospechoso o pequeño carcinoma diferenciado
Tiroidectomía subtotal	Resección de la mayor parte, dejando 2–4 g de tejido	Bocio multinodular benigno
Tiroidectomía total	Extirpación completa de ambos lóbulos y el istmo	Cáncer tiroideo, hipertiroidismo refractario, bocio compresivo
Tiroidectomía con vaciamiento ganglionar	Extirpación de tiroides + linfadenectomía cervical	Carcinoma papilar o medular con compromiso ganglionar

2.3 Fisiopatología del hipoparatiroidismo postoperatorio

Durante la cirugía puede haber:

- Extirpación inadvertida de glándulas paratiroides.
 - Isquemia de las mismas por lesión de vasos que las nutren.
→ Resultado: **disminución de PTH y de calcio sérico**, con hipocalcemia sintomática.
-

3. Clínica (signos, síntomas y diagnóstico diferencial)

3.1 Indicaciones clínicas de tiroidectomía

A. Enfermedades benignas

1. Bocio multinodular:

- Compresión (disnea, disfagia, disfonía).
- Crecimiento rápido o asimétrico.
- Sospecha citológica de malignidad.

2. Nódulo tiroideo único:

- Resultado sospechoso en biopsia por aspiración (Bethesda IV–VI).
- Crecimiento progresivo.

3. Hipertiroidismo refractario:

- Enfermedad de Graves no controlada con fármacos o yodo radiactivo.
- Pacientes con contraindicación a radioyodo (embarazo, lactancia).

B. Enfermedades malignas

1. Carcinoma diferenciado (papilar, folicular):

- Confirmado o altamente sospechoso.
- Tamaño >1 cm, multifocalidad, invasión capsular o ganglionar.

2. Carcinoma medular:

- Confirmado por calcitonina elevada o mutación RET.
- Requiere tiroidectomía total + vaciamiento cervical.

3. Carcinoma anaplásico o metastásico:

- En algunos casos, tiroidectomía paliativa para desobstrucción aérea.
-

3.2 Presentación clínica previa a cirugía

- Masa cervical anterior (asintomática o con compresión).
 - Disnea o disfagia por compresión traqueal/esofágica.
 - Disfonía (compromiso del nervio laríngeo).
 - Signos de hipertiroidismo o hipotiroidismo, según patología.
-

3.3 Diagnóstico diferencial de masas tiroideas

Patología	Características
Bocio multinodular	Masa irregular, móvil con la deglución
Carcinoma papilar	Masa dura, adherida, ganglios cervicales
Quiste tirogloso	Línea media, móvil con la protrusión de lengua
Tiroiditis de Hashimoto	Tiroides aumentada, firme, hipotiroidismo
Tiroiditis subaguda (de Quervain)	Dolorosa, febril, VHS elevada

4. Exámenes complementarios y criterios diagnósticos

Examen	Utilidad
TSH, T4 libre, T3	Evalúan función tiroidea preoperatoria

Ecografía de tiroides y cuello	Evalúa tamaño, nodularidad, adenopatías
Punción aspirativa con aguja fina (PAAF)	Diagnóstico de malignidad (Bethesda)
TAC / RNM cervical	En bocios voluminosos o retroesternales
Calcio y PTH	Basales y postoperatorios
Laringoscopia preoperatoria	Si disfonía previa o cirugía previa de cuello

5. Tratamiento (según guías MINSAL y ATA 2022)

5.1 Preparación preoperatoria

- Eutiroidismo previo a cirugía (control hormonal).
 - En hipertiroidismo: propiltiouracilo o metimazol + β -bloqueo (propranolol).
 - En Graves: lugol 10 días antes para disminuir vascularización.
 - Suspender anticoagulantes y AAS 5–7 días antes.
 - Evaluación anestésica y cardiológica.
-

5.2 Técnica quirúrgica

1. Incisión cervical baja transversa (de Kocher).
2. Identificación y ligadura de arterias tiroideas.
3. Preservación de nervios laríngeos y glándulas paratiroides.
4. Hemostasia cuidadosa.

5. Colocación opcional de drenaje (según sangrado).
6. Cierre por planos.

5.3 Cuidados postoperatorios

- Vigilancia de **calcemia y PTH** en primeras 24–48 h.
- Evaluar **voz y reflejo de tos** (lesión laríngea).
- Retiro de drenaje en 24–48 h si bajo débito.
- Reemplazo con **levotiroxina** si tiroidectomía total.
- Evaluación histopatológica definitiva de la pieza.

6. Complicaciones y pronóstico

6.1 Complicaciones tempranas

Complicación	Frecuencia	Mecanismo	Manifestaciones clínicas	Manejo
Hemorragia / hematoma cervical	1–2%	Sangrado arterial o venoso	Disnea súbita, estridor, distensión cervical	Abrir herida y evacuar inmediatamente
Lesión del nervio laríngeo recurrente	1–3% unilateral	Lesión o tracción	Disfonía, voz bitonal, tos débil	Evaluar con laringoscopia; fisioterapia o reintervención si bilateral

Lesión del nervio laríngeo superior externo	1–5%	Lesión al ligar arteria tiroidea superior	Dificultad para tonos agudos	Rehabilitación foniátrica
Hipocalcemia transitoria	20–30%	Isquemia o resección paratiroidea	Parestesias, tetania, signo de Chvostek o Trousseau	Calcio IV y oral, vitamina D
Hipoparatiroidismo permanente	1–3%	Lesión definitiva de paratiroides	Hipocalcemia persistente	Calcio oral crónico + calcitriol
Infección de herida	<1%	Contaminación quirúrgica	Eritema, dolor local	Antibióticos, drenaje local

6.2 Complicaciones tardías

- **Hipotiroidismo:** por tiroidectomía total; requiere reemplazo permanente.
- **Cicatriz hipertrófica o queloide:** principalmente en pieles pigmentadas.
- **Recurrente / residiva tumoral:** en carcinoma diferenciado (vigilancia con Tg y ecografía).
- **Parálisis bilateral de cuerdas vocales:** rara, pero puede requerir traqueostomía.

6.3 Pronóstico

- Mortalidad operatoria: <0,5%.
- Excelente pronóstico en carcinoma diferenciado si resección completa y seguimiento adecuado.
- Hipoparatiroidismo y disfonía son las secuelas más frecuentes a largo plazo.

7. Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM



Perlas

1. **Indicación más frecuente:** nódulo tiroideo sospechoso de malignidad.
2. **Lesión más temida:** daño del nervio laríngeo recurrente (disfonía postoperatoria).
3. **Signo precoz de hipocalcemia:** parestesias periorales o signo de Chvostek positivo.
4. **Tratamiento del hipoparatiroidismo:** calcio oral + calcitriol.
5. **Tiroidectomía total = reemplazo con levotiroxina de por vida.**
6. **Hemorragia cervical postoperatoria** → emergencia vital: abrir herida inmediatamente.
7. **Control de calcemia a las 6 y 24 h postcirugía** es obligatorio.



Errores comunes

- Omitir evaluación de voz y laringoscopia preoperatoria.
- No asegurar eutiroidismo antes de cirugía en hipertiroidismo (riesgo de crisis tiroidea).
- No controlar calcemia precozmente.
- Subestimar disnea por hematoma compresivo (requiere descompresión inmediata).
- No reemplazar hormona tiroidea tras tiroidectomía total.

8. Resumen final (5–7 ideas clave)

1. **Tiroidectomía:** extirpación parcial o total del tiroides por patología benigna o maligna.
2. **Indicaciones principales:** bocio compresivo, cáncer tiroideo, hipertiroidismo refractario.
3. **Complicaciones tempranas:** sangrado, lesión nerviosa, hipocalcemia.
4. **Hemorragia cervical postoperatoria** es una urgencia vital.
5. **Lesión del NLR → disfonía; hipoparatiroidismo → hipocalcemia.**
6. **Requiere reemplazo con levotiroxina tras tiroidectomía total.**
7. **Pronóstico excelente** si cirugía segura y seguimiento endocrinológico adecuado.